



Comunicação que Transforma: Avaliação da Dor Crônica na APS

Integrando Calgary-Cambridge e SCEBS para uma abordagem humanizada



UFPEL





Preparação para a consulta



Ambiente acolhedor

Garanta privacidade e conforto, além de minimizar interrupções durante o atendimento.



Revisão prévia

Consulte o prontuário do paciente, mas evite formar vieses prévios.



Autocuidado profissional

Esteja emocionalmente disponível. Evite realizar consultas sob estresse.

Técnicas de escuta ativa



Imagem: Designed by Magnific



Repetição estratégica (eco)

Repita as últimas palavras do paciente.



Tempo sagrado

Permita, pelo menos, 2 minutos de fala ininterrupta no início da consulta.



Anotações breves

Faça registros sem perder o contato visual com a pessoa atendida.

Empatia clínica na prática: mais do que se colocar no lugar do outro



Imagem: Designed by Magnific

Linguagem não verbal

Contato visual, acenos de cabeça e postura inclinada demonstram interesse e aumentam a percepção de acolhimento.

Validação da experiência

"Imagino que essa dor tem sido bastante cansativa para você."

Evite minimizar

Nunca diga frases como "Isso é normal para sua idade", pois invalidam a experiência da pessoa com dor crônica.



Estrutura híbrida para consultas: Calgary-Cambridge + SCEBS adaptado

1

Primeiros 5 minutos

Foco nas dimensões Somáticas (S) e impacto Emocional (E) do SCEBS.

2

Minutos 6 - 10

Combinação de coleta ativa (Calgary) com 2 perguntas-chave por dimensão (SCEBS).

3

Minutos 10 - 15

Pactuação com linguagem acessível e priorização das necessidades da pessoa com dor crônica.



Imagem: Designed by Magnific



Pactuação: transformando o "eu acho" em "nós decidimos"

Identificar prioridades

1

Pergunte à pessoa atendida quais são as suas maiores preocupações e objetivos.

Explorar opções

2

Apresente as diferentes opções de tratamento, explicando os benefícios e riscos de cada uma.

Tomar decisões

3

Juntos, decidam qual é o melhor plano de tratamento para a pessoa atendida, levando em consideração as suas preferências e valores.



Imagem: Designed by Magnific

A pactuação é um processo colaborativo que envolve o usuário na tomada de decisões sobre o seu próprio cuidado. Ao transformar o "eu acho" em "nós decidimos", o profissional de saúde empodera a pessoa atendida e promove a adesão ao tratamento.



Dimensões SCEBS na consulta

Cognições (C)

"O que acha que piora essa dor?"

"Você tem medo de que seja algo grave?"



Comportamentos (B)

"O que deixou de fazer por causa da dor?"

"Como tenta aliviá-la?"



Somático (S) e Emoções (E)

"Onde exatamente dói?"

"Como se sente emocionalmente com essa dor?"



Sociais (S)

"Como cuidar dos netos afeta a sua dor?"

"A sua família sabe como você está se sentindo?"





Caso Clínico

Maria (65 anos) com lombalgia crônica



Minutos 0-5:

Foco em Sensações (S) e Emoções (E) – SCEBS



Acolhimento

Profissional acolhe: "Oi Maria. Como você está? Conte-me, como está sua dor nas costas ultimamente?"

Maria: "Tá insuportável! Piora quando limpo a casa e à noite... Nem consigo dormir direito."



Escuta ativa

Profissional oferece escuta ativa e repete estrategicamente a informação: "Então, a dor aumenta com tarefas domésticas e atrapalha seu sono..."

Profissional avalia a localização e a intensidade
"Onde exatamente dói?
Pode me mostrar?"

Maria: "Aqui na parte de baixo das costas. Parece um peso que queima!"



Empatia e investigação emocional

Profissional demonstra empatia e procura investigar aspectos emocionais: "Deve ser muito frustrante conviver com isso. Como a senhora se sente emocionalmente com essa dor?"

Maria suspira e chora: "Sinto que não dou conta... Cuido dos meus netos, mas fico irritada com a dor e às vezes desconto neles, sabe? Eles não tem culpa, mas acho que vou enlouquecer. Sempre trabalhei e agora mal consigo cuidar da casa."



Caso Clínico

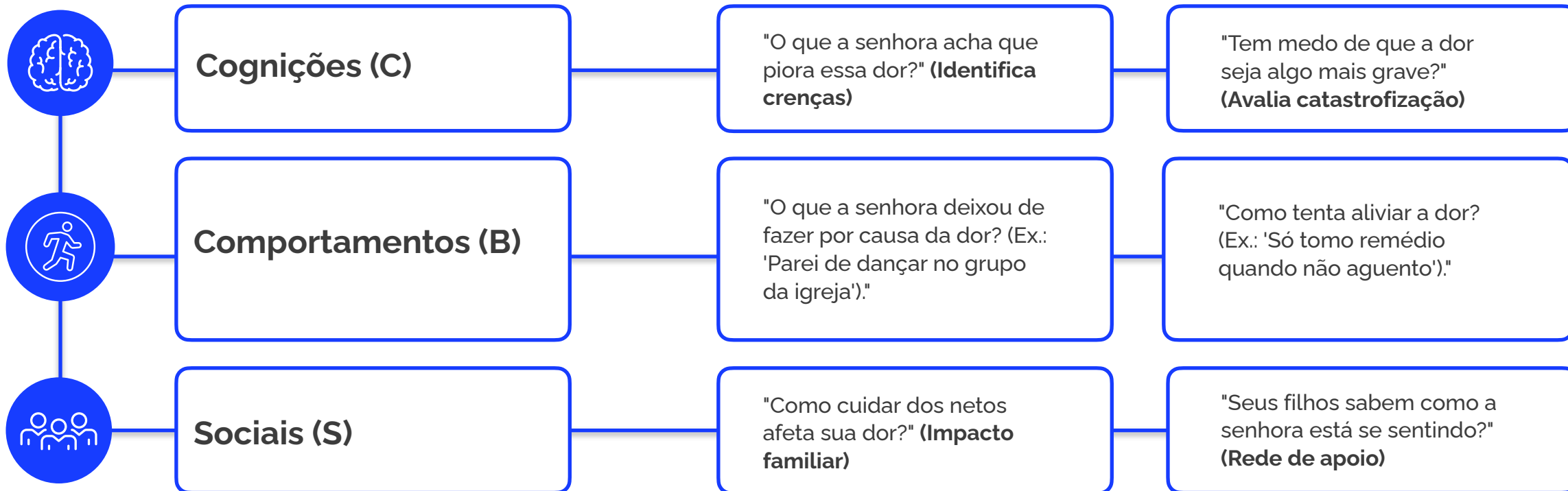
Maria (65 anos) com lombalgia crônica



Minutos 6-10:

Escuta Ativa (Calgary-Cambridge)

+ 2 Perguntas por Dimensão (SCEBS)



Médico(a) faz anotações breves sem perder o contato visual, resume e valida: "Então, resumindo: a dor queima na lombar, piora com esforço, atrapalha seu sono e a deixa sobrecarregada com os netos. É isso?"

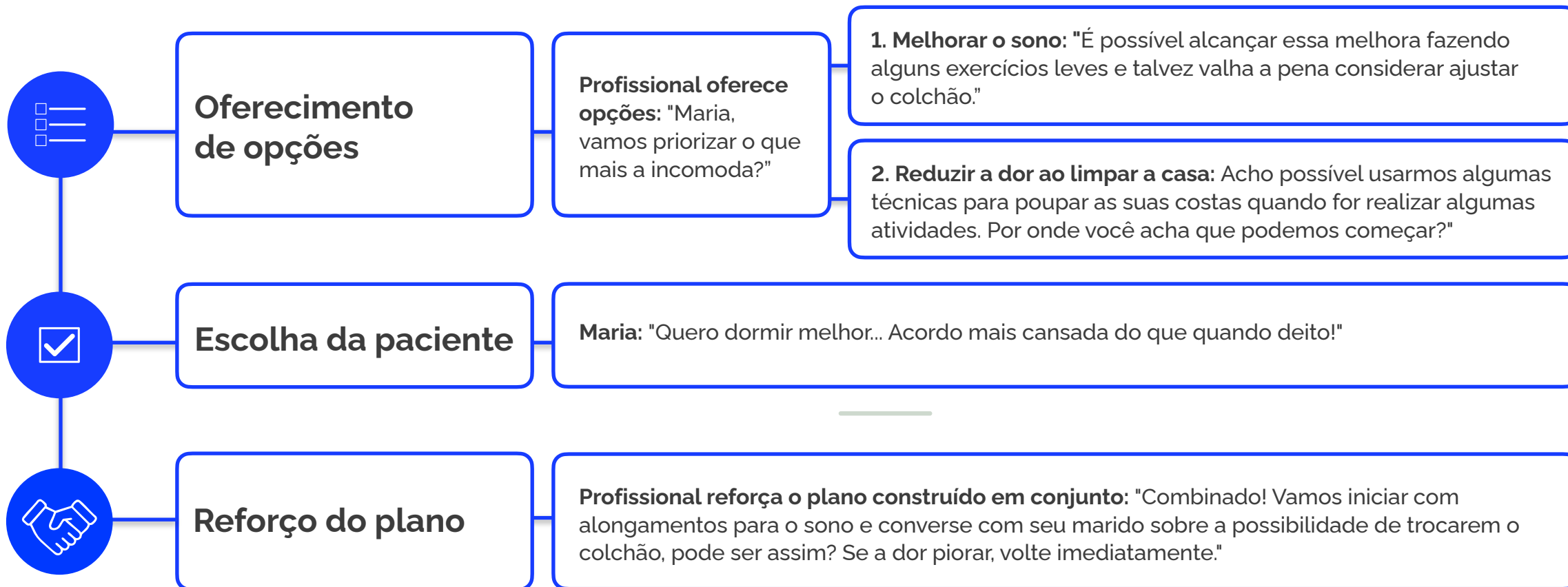


Caso Clínico

Maria (65 anos) com lombalgia crônica



Minutos 10-15:
Pactuação com Linguagem Acessível





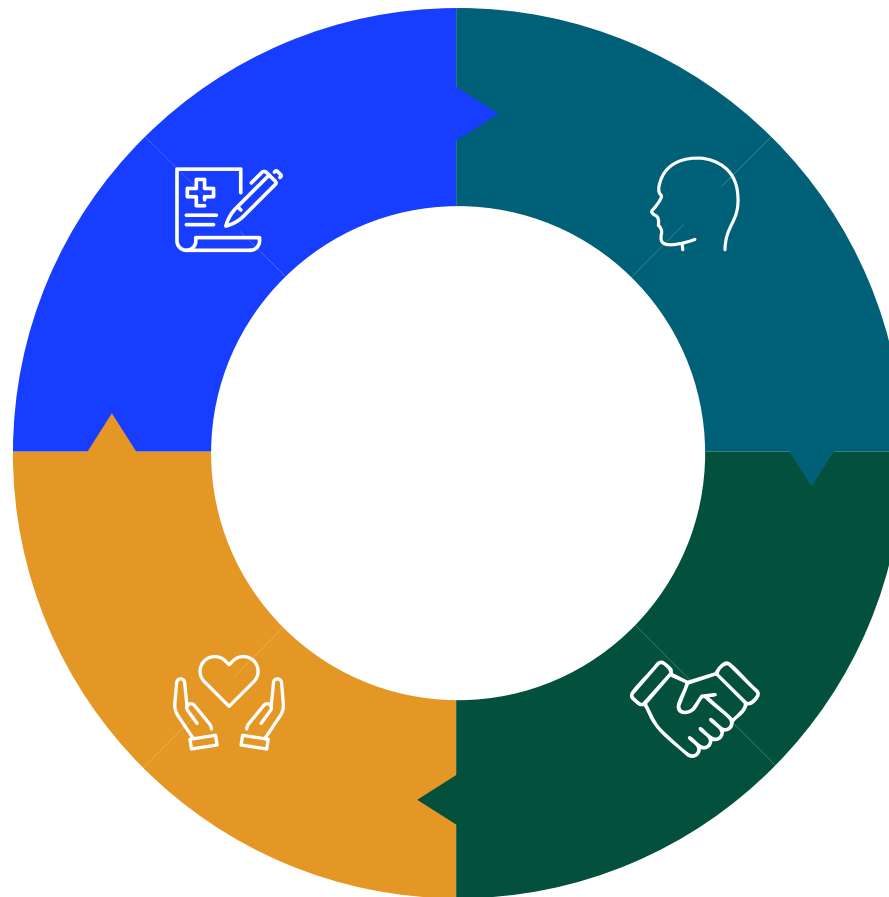
Técnicas de comunicação utilizadas na consulta

SCEBS

Abordagem estruturada que explora **S**ensações, **C**ognições, **E**moções, **C**omportamentos e aspectos **S**ociais da dor

Empatia clínica

Reconhecimento das emoções e validação dos sentimentos durante todo o atendimento



Calgary-Cambridge

Método de comunicação centrada no paciente, adaptável a diferentes contextos

Pactuação colaborativa

Construção conjunta do plano terapêutico com linguagem acessível e respeito à autonomia do paciente



Referências bibliográficas

BARRY, C. A. *et al.* Patients' unvoiced agendas in general practice consultations. **BMJ**, [s. l.], v. 320, n. 7244, p. 1246–1250, 2001. Disponível em: <https://doi.org/10.1136/bmj.320.7244.1246>. Acesso em: 12 jan. 2026.

BECKMAN, H. B.; FRANKEL, R. M. The effect of physician behavior on the collection of data. **Annals of Internal Medicine**, [s. l.], v. 101, n. 5, p. 692–696, 1984. Disponível em: <https://doi.org/10.7326/0003-4819-101-5-692>. Acesso em: 12 jan. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. **HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização: a humanização como eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS**. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 51 p. (Série B. Textos Básicos de Saúde). Disponível em: <https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/biblioteca/humanizasus/>. Acesso em: 01 jul. 2026.

CARRIÓ, F. **Entrevista clínica**: habilidades de comunicação para profissionais de saúde. Porto Alegre: Artmed, 2012.

DOHMS, M. C.; COLLARES, C. F.; TIBERIO, I. C. Brazilian version of Calgary-Cambridge Observation Guide 28-item version: Cross-cultural adaptation and psychometric properties. **Clinics**, [s. l.], v. 76, p. e1706, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.6061/clinics/2021/e1706>. Acesso em: 12 jan. 2026.

DOHMS, M.; GUSSO, G. **Comunicação clínica**: aperfeiçoando os encontros em saúde. Porto Alegre: Artmed, 2021.

KURTZ, S.; SILVERMAN, J.; DRAPER, J. **Teaching and learning communication skills in medicine**. 2. ed. Oxford: Radcliffe Publishing, 2005.

PLATT, F. W.; GORDON, G. H. **Field guide to the difficult patient interview**. 2. ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 1999.

PORTOCARRERO-GROSS, R. Modelo de consulta e habilidades de comunicação. In: DUNCAN, B. B. *et al.* (ed.). **Medicina ambulatorial**: condutas de atenção primária baseadas em evidências. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2022.

SANTOS, M. R. P. *et al.* Transcultural adaptation into Portuguese of an instrument for pain evaluation based on the biopsychosocial model. **Fisioterapia e Movimento**, [s. l.], v. 30, p. 183-195, 2017. Suplemento 1. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-5918.030.S01.A018>. Acesso em: 12 jan. 2026.



Ficha técnica

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Secretaria de Atenção Primária à Saúde - SAPS
Departamento de Promoção da Saúde - DEPROS
Coordenação de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - COPICS

Coordenação Geral:
Paulo Roberto Sousa Rocha
COPICS/DEPROS/SAPS/MS
Daniel Miele Amado
COPICS/DEPROS/SAPS/MS

Equipe Técnica:
Nathalia Oliveira da Silva
COPICS/DEPROS/SAPS/MS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Reitoria
Ursula Rosa da Silva

Vice-Reitoria
Eraldo dos Santos Pinheiro

Coordenação Geral
Julieta Carriconde Fripp
Coordenadora da Cuidativa (Centro Regional de Referência em Cuidados Paliativos FAMED/UFPEL), Diretora da Faculdade de Medicina da UFPEL.

Coordenadora Adjunta
Simone da Fonseca Sanghi
Assistente Social da Cuidativa (Centro Regional de Referência em Cuidados Paliativos FAMED/UFPEL), Colaboradora dos processos de Gestão na Cuidativa.



UFPEL





Ficha técnica

CRÉDITOS DO CURSO

Coordenação Geral

Paulo Roberto Sousa Rocha
Julieta Carriconde Fripp
Simone da Fonseca Sanghi

Apoio Administrativo / Secretaria

Luciano Avila dos Santos

Coordenação de Conteúdo

Amirah Adnan Salman
Bárbara Cury Soubhia
Manuela Samir Maciel Salman

Consultoria e Revisão de Conteúdos

Amirah Adnan Salman
Andrea Cristina Lovato Ribeiro
Bárbara Cury Soubhia
Julieta Carriconde Fripp
Manuela Samir Maciel Salman
Nathalia Oliveira da Silva
Paulo Roberto Sousa Rocha
Simone da Fonseca Sanghi

Coordenação Pedagógica

Amirah Adnan Salman
Andrea Cristina Lovato Ribeiro
Bárbara Cury Soubhia
Manuela Samir Maciel Salman

Coordenação de Pesquisa e Relatórios

Luiz Augusto Facchini
Elaine Thumé
Elaine Tomasi

Coordenação de Mídias e Comunicação

Samir Salman
João Rocha Rodrigues
Luana Copini Jahn

Coordenação de Tecnologia e Informação

Alessander Osório
Coordenação da Produção
Alexandre Moretto Ribeiro
Andrea Cristina Lovato Ribeiro

Revisão Gramatical/Ortográfica e ABNT

Giulia M. Delazzeri

Coordenação de Atividades e Logística de Campo:

Paulo Roberto Sousa Rocha

Produção Audiovisual

Eduardo Dias Abreu

Assistente de Produção Audiovisual

Luciana Melo

Animação

Márlon Lima

Ilustração

Mario Cau
Barlo Moreira (cores)

Diagramação e Design Gráfico

Danielle Rossi

Design Web e Programação

Vando Pinto

CRÉDITOS DESTE RECURSO DIDÁTICO

Conteúdo

Rodrigo Macedo Pacheco



UFPEL

